

Альтернативные методы предупреждения осложнений хирургического лечения туберкулеза легких

Зетов А.Ш.

Национальный центр проблем туберкулеза, г.Алматы

При хирургическом лечении туберкулеза легких многие известные виды дополнительной герметизации культи усеченного бронха не всегда решают проблему развития ее несостоятельности. [1, 2,].

В Национальном центре проблем туберкулеза с 1999 года стали применять адсорбирующее раневое покрытие Тахокомба компании «Никомед» при операциях на легких. В отделении легочной хирургии пластина Тахокомба использована у 30 пациентов. У 3 (10,0%) пациентов был туберкулезный процесс в виде туберкулем, у 24 (80,0%) был фиброзно-кавернозный туберкулез легких. У остальных 3 (10,0%) больных была пострезекционная эмпиема плевры плевры с бронхиальными свищами.

Бактериовыделителей было 16 (53,3%), из них у 8 (26,6%) выявлена полирезистентность к противотуберкулезным препаратам первого ряда. Больным произведено 30 оперативных вмешательств, из них прецизионных резекций – 3 (10,0%), сегментарных резекций – 5 (16,6%), лобэктомий – 5 (16,6%), пневмонэктомий – 10 (33,3%), трансстернальных трансперикардиальных окклюзий главного бронха – 4 (13,3%), окклюзий главного бронха из контрлатерального доступа – 2 (6,7%), а пластика бронхиального свища была выполнена 1 (3,3%) пациентке.

Из 30 больных, которым для дополнительной герметизации культи было применено адсорбирующее раневое покрытие Тахокомб, эффективность хирургического лечения достигнута у 28 (93,3%). У 2 (6,7%) больных, перенесших трансстернальную трансперикардиальную окклюзию главного бронха с дополнительной герметизацией центрального и периферического концов бронха, в сроки 7 и 18 дней возникла реканализация.

В 2002г. был разработан и внедрен в практику – способ пластики культи бронха аутоангиотрансплантатом после пневмонэктомий и лобэктомий у больных туберкулезом легких. Оперирован 21 пациент с применением аутоангиопластики культи резецированного бронха. У всех пациентов установлен диагноз фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Бактериовыделителей было 20 (95,2%), из них у 16 (76,2%) была выявлена резистентность к противотуберкулезным препаратам основного ряда. Среди оперативных вмешательств было 5 (23,8%) лобэктомий, 16 (76,2%) пневмонэктомий. В ближайший послеоперационный период у 2 (9,5%) больных после пневмонэктомии развилась клиника бронхиального свища.

Отсутствие реакции иммунного отторжения, надежность пластики бронха, предохраняющая шов культи в период ее вторичного заживления от формирования сообщения между

культей и плевральной полостью, позволили достигнуть эффективности применения аутоангиотрансплантата 90,5%.

С 2009 года стала применяться проленовая сетка фирмы «Джонсон и Джонсон» при различных видах операций на легких с целью профилактики возникновения бронхиальных свищей, которая использована у 26 больных туберкулезом легких.

По клиническим формам туберкулеза была в 2 (7,7%) случаях, кавернозный туберкулез легкого в 4 (15,4%) и фиброзно-кавернозный туберкулез легкого в 20 (76,9%) случаях, один из которых был с эмпиемой плевры с бронхиальным свищем. У всех больных установлена резистентность к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда.

Бацилловыделение при поступлении было у 8 (30,7%) больных, непосредственно перед операцией у 6 (23,0%) больных.

Всего было выполнено 26 оперативных вмешательств. Способ заключался в укреплении механического шва или культи усеченного бронха путем наложения поверх него лоскута проленовой сетки и фиксации П-образными швами на атравматической игле

В ближайший послеоперационный период осложнения в виде развития бронхиального свища не наблюдалось. Преимуществом способа явилось то, что при резекции легкого укрепление механического шва путем наложения и фиксации поверх него проленовой сетки улучшает условия для заживления и предупреждает развитие бронхиального свища.

В лечении туберкулеза первостепенное значение имеет рациональная химиотерапия с учетом лекарственной чувствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам. Хирургические методы используются при неэффективности консервативного лечения, и ввиду роста лекарственно-устойчивого туберкулеза они требуют постоянного совершенствования. Разработанные методы применения пластины Тахокомба, аутоангиотрансплантата и проленовой сетки показали их высокую эффективность (более 90,5%) и позволили сделать вывод, что они являются эффективными альтернативными дополнительными средствами профилактики бронхиальных свищей, которых следует рекомендовать для более широкого применения во фтизиохирургии.

Литература

1. Абисатов Х.А. Плевризация культи бронха после обработки ее аппаратом УКБ -25. //Здравоохранение Казахстана. – 1963, №3, С. 31-34.
2. Григорян В.А., Скляр П.М. Влияние способа укрытия культи бронха на исходы оперативного лечения. //Грудная хирургия, 1987, №2, С.59-63.